DU FINDER DET OG VED, HVAD DU SKAL GØRE™

Udstrækningsguide efter Kropsregion

Udstrækningerne for alle 60 muskler samlet ét sted, efter kropsregion og i samme rækkefølge som i atlasset og protokollerne.

Indhold

1 · Sådan udfører du en udstrækning

2 · Hoved, ansigt og nakke

3 · Skulder, overarm, underarm og hånd

4 · Ryg, rygsøjle og truncus

5 · Bækken, hofte og balder

6 · Lår, underben og fod

Næste skridt

AFSNIT 1

Sådan udfører du en udstrækning

Tre regler for hver udstrækning.

Regler

- [ ] Gå langsomt ind i udstrækningen, på udåndingen og uden at fjedre.
- [ ] Du skal mærke et let træk, aldrig smerte: gør det ondt, så slip lidt.
- [ ] Hold 20–30 sekunder, 3 gentagelser; stræk altid ud efter behandlingen.

AFSNIT 2

Hoved, ansigt og nakke

Til behandleren og patienten.

Trapezius – øvre fibre

Hovedet lateralflekteres til modsat side med let fleksion; siddende holder patienten fast under stolen med hånden på samme side.

3 × 20–30 sek.

Sternocleidomastoideus (SCM)

Hovedet lateralflekteres til modsat side, og derefter roteres hagen langsomt mod den behandlede side; let ekstension kun hvis det ikke giver svimmelhed.

3 × 20–30 sek.

Masseter

Langsom åbning af munden med tungespidsen mod ganen; terapeutens to fingre fører forsigtigt kæben nedad.

3 × 20–30 sek.

Temporalis

Langsom åbning af munden, mens terapeutens fingre glider opad over tindingen.

3 × 20–30 sek.

Pterygoideus lateralis

Langsom retraktion af underkæben (patienten trækker hagen let bagud) og derefter langsom lukning af munden.

3 × 20–30 sek.

Pterygoideus medialis

Langsom åbning af munden med kæben let forskudt mod modsat side.

3 × 20–30 sek.

Splenius capitis

Hovedet i fleksion og roteret mod modsat side.

3 × 20–30 sek.

Splenius cervicis

Hovedet i fleksion med lateralfleksion og rotation mod modsat side.

3 × 20–30 sek.

Suboccipitale muskler

Hageretraktion (hovedet glider lige bagud) og derefter et let «nik» fremad.

3 × 20–30 sek.

Semispinalis capitis

Hovedet i fleksion med let rotation til siden.

3 × 20–30 sek.

Levator scapulae

Hovedet i fleksion og roteret mod modsat side (næsen mod armhulen), hånden på den behandlede side i nakken.

3 × 20–30 sek.

Scaleni

Hovedet lateralflekteres til modsat side med let ekstension; terapeuten stabiliserer kravebenet på den behandlede side nedad.

3 × 20–30 sek.

AFSNIT 3

Skulder, overarm, underarm og hånd

Til behandleren og patienten.

Infraspinatus

Armen på den behandlede side føres foran brystet, og den anden hånd trækker albuen ind mod brystet; eller hånden om på ryggen.

3 × 20–30 sek.

Supraspinatus

Armen på den behandlede side om på ryggen, den anden hånd trækker blidt håndleddet mod modsat side.

3 × 20–30 sek.

Teres minor

Armen føres foran brystet, albuen trækkes ind mod brystet.

3 × 20–30 sek.

Subscapularis

Armen udadroteret, albuen i 90°, håndfladen føres blidt bagud (mod dørkarmen).

3 × 20–30 sek.

Deltoideus

Forreste fibre: armen bagud; bageste fibre: armen føres foran brystet.

3 × 20–30 sek.

Pectoralis major

Udstrækning i døråbning: underarmen mod dørkarmen, albuen i skulderhøjde, kroppen tager langsomt et skridt frem.

3 × 20–30 sek.

Pectoralis minor

Skuldrene tilbage og ned; i dørkarmen er albuen over skulderhøjde.

3 × 20–30 sek.

Rhomboidei

Armene krydses foran kroppen (kram dig selv), ryggen krummes let.

3 × 20–30 sek.

Serratus anterior

Armen bagud og skulderbladet trukket ind mod columna; med en dyb indånding.

3 × 20–30 sek.

Latissimus dorsi

Armen over hovedet, kroppen lateralflekteret mod modsat side.

3 × 20–30 sek.

Biceps brachii

Albuen strakt, underarmen proneret, armen bagud.

3 × 20–30 sek.

Triceps brachii

Armen over hovedet, albuen helt bøjet, den anden hånd skubber den blidt bagud.

3 × 20–30 sek.

Underarmens ekstensorer (ECRL, ECRB, extensor digitorum)

Albuen strakt, håndled og fingre flekteret, den anden hånd trækker blidt nedad.

3 × 20–30 sek.

Underarmens fleksorer

Albuen strakt, håndfladen opad, fingrene trukket bagud.

3 × 20–30 sek.

AFSNIT 4

Ryg, rygsøjle og truncus

Til behandleren og patienten.

Trapezius – midterste fibre

Armene krydses foran kroppen, ryggen krummes.

3 × 20–30 sek.

Trapezius – nedre fibre

Armene frem og op, ryggen krummet.

3 × 20–30 sek.

Serratus posterior superior

Armen krydset foran kroppen, ryggen krummet.

3 × 20–30 sek.

Iliocostalis thoracis

Fremadbøjning fra siddende, med overkroppen let roteret mod modsatte side.

3 × 20–30 sek.

Iliocostalis lumborum

Rygleje med knæene trukket op mod brystet.

3 × 20–30 sek.

Longissimus thoracis

Fremadbøjning fra siddende eller rygleje med knæene mod brystet.

3 × 20–30 sek.

Multifidus

Rygleje med knæene mod brystet og let rotation til siden.

3 × 20–30 sek.

Quadratus lumborum

Sidebøjning stående eller i sideleje, med den øverste arm over hovedet.

3 × 20–30 sek.

Rectus abdominis

Rygleje med en pude under lænden, armene over hovedet.

3 × 20–30 sek.

Obliquus externus abdominis

Rygleje med knæene faldende mod modsatte side, skuldrene i underlaget.

3 × 20–30 sek.

AFSNIT 5

Bækken, hofte og balder

Til behandleren og patienten.

Gluteus maximus

Rygleje, knæet trækkes mod den modsatte skulder.

3 × 20–30 sek.

Gluteus medius

I sideleje hænger det øverste ben ud over kanten af briksen bag kroppen; eller stående med krydsede ben, sidebøjning.

3 × 20–30 sek.

Gluteus minimus

Rygleje, benet krydser over mod den modsatte side.

3 × 20–30 sek.

Piriformis

Rygleje, anklen fra det behandlede ben på det andet knæ, det andet lår trukket mod brystet («4-tals»-udstrækning).

3 × 20–30 sek.

Iliopsoas

Udfaldsstilling (lunge): det bageste knæ i gulvet, bækkenet skubbes frem.

3 × 20–30 sek.

Tensor fasciae latae

I sideleje er det øverste ben strakt og hænger bagud og nedad.

3 × 20–30 sek.

Adductor longus og brevis

Siddende med fodsålerne samlet (sommerfugl), knæene falder nedad.

3 × 20–30 sek.

Adductor magnus

Siddende med spredte ben, fremadbøjning.

3 × 20–30 sek.

Pectineus

Benet i abduktion og strakt, let bagud.

3 × 20–30 sek.

Sartorius

Hoften i ekstension med let indadrotation (udfaldsstilling).

3 × 20–30 sek.

AFSNIT 6

Lår, underben og fod

Til behandleren og patienten.

Rectus femoris

Maveleje eller stående, hælen trækkes mod ballen, hoften i ekstension.

3 × 20–30 sek.

Vastus medialis

Knæet maksimalt bøjet (hælen mod ballen).

3 × 20–30 sek.

Vastus lateralis

Knæet maksimalt bøjet, benet i let indadrotation.

3 × 20–30 sek.

Biceps femoris

Rygleje, løft af det strakte ben med anklen i dorsalfleksion.

3 × 20–30 sek.

Semitendinosus og semimembranosus

Rygleje, løft af det strakte ben, let ud til siden.

3 × 20–30 sek.

Gastrocnemius

Stående foran en væg, det bageste ben strakt, hælen i gulvet.

3 × 20–30 sek.

Soleus

Stående foran en væg, det bageste knæ let bøjet, hælen i gulvet.

3 × 20–30 sek.

Tibialis anterior

Ankel og tæer i plantarfleksion (siddende med fodryggen nedad).

3 × 20–30 sek.

Peroneus (fibularis) longus

Foden drejet indad og i plantarfleksion.

3 × 20–30 sek.

Tibialis posterior

Foden drejet udad og i dorsalfleksion.

3 × 20–30 sek.

Extensor digitorum longus

Tæer og ankel i plantarfleksion.

3 × 20–30 sek.

Flexor digitorum brevis

Tæerne trukket opad, anklen i dorsalfleksion.

3 × 20–30 sek.

Abductor hallucis

Storetåen trukket indad (mod de andre tæer), anklen i dorsalfleksion.

3 × 20–30 sek.

Quadratus plantae

Tæer og ankel i dorsalfleksion.

3 × 20–30 sek.

Næste skridt

I dag: prøv udstrækningerne for nakke og skulder på dig selv, så du kan forklare dem præcist for din patient.